



Diário Clínico

Consulta Externa

05-Ago-2024 Dr(a). Ricardo Lemos (HUC-CARDIOLOGIA)

Consulta vigilância FA paroxística. AP: FA paroxística dx 02/2023; DC ileocólica, clinicamente em remissão sob azatioprina/mesalazina; perturbação depressiva major, remissão parcial, seguida em Psiquiatria. Appendicectomy 2015. Esteatose hepática ligeira conhecida. Anemia ligeira previamente atribuída a DII. Sem recorrência de quadro de GEA 04/2025.

Sem episódios de palpitações sustentadas, irregularidade do pulso, pré-síncope, síncope, dor torácica, dispneia, ortopneia, DPN ou edemas desde última observação. Mantém ocasional sensação de “batimento isolado”, breve, não limitante, sem relação com esforço e sem registo de arritmia no Holter prévio. Sem hemorragia major ou menor sob ACO; nega epistaxis, gengivorragia, hematúria, melenas/rectorragias ou equimoses anómalas. Tolerância ao esforço preservada. Sem consumo excessivo de álcool/estimulantes. Queixas ocasionais de insónia inicial, contexto ansioso, sem agravamento afectivo franco.

MH: apixabano 5 mg 2id, bisoprolol 2,5 mg id, azatioprina 100 mg id, mesalazina 1,2 g 2id, sertralina 100 mg id. Boa adesão referida. Sem efeitos adversos cardiovasculares aparentes. Alergia conhecida a sulfamidas, exantema maculopapular.

EO: bom estado geral, corada, hidratada, eupneica em repouso. TA 118/72 mmHg, FC 64 bpm regular, SpO2 99% ar ambiente, T 36,4 °C. Auscultação cardíaca com S1/S2 normofonéticas, ritmo regular, sem sopros, sem galope. Campos pulmonares livres, sem crepitações. Sem edemas periféricos, pulsos periféricos palpáveis e simétricos.

ECD/MCDTs: ECG realizado em consulta, calibração 25 mm/s e 10 mm/mV, ritmo sinusal regular a 62 bpm. Onda P de morfologia habitual, condução AV preservada, PR 158 ms. QRS estreito, 86 ms, sem bloqueios de ramo ou alterações de condução intraventricular. Eixo eléctrico intermédio, QT 404 ms, QTc 410 ms. Segmento ST isoeléctrico, ondas T sem alterações significativas de repolarização, sem sinais electrocardiográficos de isquemia aguda ou sobrecarga aurículo-ventricular.

Holter 24h previamente efectuado: tempo útil de registo 23h47min, ritmo sinusal predominante durante a totalidade da monitorização, FC média 68 bpm, mínima 47 bpm em período nocturno, máxima 128 bpm em actividade diurna. Sem pausas superiores a 2,0 s, sem bloqueio AV de alto grau e sem bradicardia clinicamente relevante. Identificados 34 batimentos supraventriculares prematuros isolados, monomórficos, sem salvas de taquicardia supraventricular. Extrassistolia ventricular muito escassa, 7 ESV isoladas, sem pares, tripletos ou TV não sustentada. Não documentados episódios de FA/flutter, taquicardia atrial sustentada ou outra arritmia supraventricular sustentada no período analisado. Diário de sintomas sem correspondência arritmica; uma queixa de palpitação coincidiu com ritmo sinusal 72 bpm, com ESV isolada adjacente.



Diário Clínico

Consulta Externa

Ecocardiograma transtorácico de controlo, estudo prévio revisto: cavidades cardíacas sem dilatação significativa, AE discretamente no limite superior da normalidade, volume indexado 31 mL/m². VE de dimensões normais, sem hipertrofia, função sistólica global preservada, FEVE estimada 62% por Simpson biplano, sem alterações segmentares da contractilidade. Função diastólica sem evidência de elevação das pressões de enchimento. VD não dilatado, função sistólica conservada, TAPSE 23 mm. Válvulas sem lesão estrutural relevante; insuficiência mitral e tricúspide mínimas, sem estenoses. PSAP estimada 24 mmHg, ausência de derrame pericárdico e raiz aórtica de dimensões normais.

Analítica recente: Hb 11,8 g/dL, VGM 87 fL, leucócitos 6,4x10⁹/L, plaquetas 278x10⁹/L. Creatinina 0,78 mg/dL, TFG_e 96 mL/min/1,73m², ureia 29 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Mg 2,0 mg/dL. AST 21 U/L, ALT 27 U/L, GGT 31 U/L, bilirrubina total 0,5 mg/dL. TSH 1,84 mUI/L, T4L 1,12 ng/dL. PCR 2,1 mg/L. Sem alteração renal, hepática, electrolítica ou tireoideia condicionante de estratégia antiarrítmica/anticoagulante.

FA paroxística, sem recorrência clínica ou documentada; CHA₂DS₂-VASc revisto, mantém indicação para anticoagulação. Manter apixabano 5 mg 2id e bisoprolol 2,5 mg id, sem indicação actual para AAD ou estratégia invasiva. Alertada para sinais de alarme: palpitações persistentes, síncope/pré-síncope, dispneia, dor torácica, hemorragia. Reforçadas medidas gerais, evitar desidratação e estimulantes. Seguimento em Cardiologia em 12 meses; antecipar se recorrência sintomática, caso em que ponderar Holter prolongado/event recorder.

20-Ago-2024 Dr(a). Inês Valente (HUC-GASTRENTEROLOGIA)

AP: DC ileocólica dx 2018, sob AZA; FA paroxística hipocoagulada; perturbação depressiva em seguimento Psiqu. Sem intercorrências infecciosas recentes. Refere bem-estar global. Sem dor abd., distensão, náuseas/vómitos. Trânsito habitual, 1-2 dejeções/dia, fezes formadas, sem urgência, muco ou rectorragias. Sem febre, perda ponderal, queixas articulares, lesões cutâneas ou oculares. Sem consumo de AINEs.

MH: azatioprina 100 mg id, mesalazina 1,2 g 2id; restante terapêutica mantida. Boa adesão, sem efeitos adversos referidos.

EO: TA 118/72 mmHg, FC 64 bpm, SatO₂ 99% AA, T 36,4°C. Bom estado geral, apirética, sem palidez marcada. Abd. plano, depressível, indolor superficial/profundamente, sem massas ou organomegalias, sem defesa. Sem edemas periféricos.

Hemograma 14/08/25: Hb 11,4 g/dL, VGM 84 fL, HGM 27 pg, leucócitos 6,2x10⁹/L, neutrófilos 3,8x10⁹/L, plaquetas 286x10⁹/L. Ferritina 24 ng/mL, Fe 58 µg/dL, transferrina 278 mg/dL, saturação 15%. PCR 1,2 mg/L, VS 11 mm/h. Creatinina 0,76 mg/dL, ureia 27 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,2 mmol/L. AST 19 U/L, ALT 21 U/L, FA 72 U/L, GGT 18 U/L,



Diário Clínico

Consulta Externa

bilirrubina total 0,5 mg/dL, albumina 4,3 g/dL. Calprotectina fecal 38 µg/g, compatível com remissão bioquímica.

Colonoscopia de vigilância 03/2025 com progressão até íleo terminal, preparação adequada. Íleo distal sem ulcerações, eritema ou estenose; válvula ileocecal permeável. Cólon sem atividade inflamatória endoscópica, padrão vascular preservado, sem erosões ou lesões aftoides. Em sigmoide identificado pólipó sésil 3 mm, excisado integralmente com pinça fria. Histologia: pólipó hiperplásico, sem displasia. Sem indicação para vigilância dirigida pelo pólipó; manter calendário endoscópico inerente à DC.

DC ileocólica em remissão clínica, analítica e endoscópica. Anemia ligeira crónica, sem agravamento. Manter AZA 100 mg id e mesalazina 1,2 g 2id. Hemograma, função hepática/renal, PCR e calprotectina antes da próxima consulta. Alertada para febre/infeção, dor abd., diarreia persistente ou hematoquécia. Reavaliação em 6 meses.

10-Set-2024 Dr(a). Inês Matos (HUC-PSIQUIATRIA)

AP: perturbação depressiva major, em remissão parcial; doença de Crohn sob imunossupressão; FA paroxística medicada. Mantém sertralina 100 mg id, boa adesão, sem efeitos adversos relevantes além de aumento ponderal progressivo referido desde início/manutenção da terapêutica.

Humor globalmente eutímico, com oscilações ligeiras reactivas a sobrecarga laboral, sem repercussão funcional major. Mantém actividade profissional e rotina familiar. Anedonia negada. Energia e iniciativa globalmente preservadas. Apetite aumentado/ingestão emocional ocasional; preocupa-se com ganho de peso, sem comportamentos compensatórios. Insónia inicial esporádica, habitualmente em períodos de maior ansiedade antecipatória; latência ~30-60 min, sem despertares frequentes, sono reparador na maioria das noites. Sem consumo de álcool excessivo, drogas ou hipnóticos não prescritos.

Sem ideação suicidária actual ou recente, sem plano, intenção ou comportamentos auto-lesivos. Sem heteroagressividade. Sem sintomas psicóticos, ideias delirantes, vivências de referência ou alterações perceptivas. Ansiedade situacional, controlável, sem crises de pânico. Insight preservado.

EO: TA 118/74 mmHg, FC 68 bpm, regular à observação, SpO2 99% AA, T 36,4°C. Sem agitação ou lentificação psicomotora marcada. Vigil, colaborante, contacto adequado. Discurso espontâneo, fluente, normofónico, pensamento organizado e sem conteúdo mórbido predominante. Atenção sustentada, orientação auto e alopsíquica mantida. Memória sem alterações grosseiras. Juízo crítico preservado.



Diário Clínico

Consulta Externa

Analítica de vigilância 03/09/2025: Hb 12,1 g/dL, VGM 88 fL, leucócitos $6,4 \times 10^9/L$, neutrófilos $3,8 \times 10^9/L$, plaquetas $274 \times 10^9/L$. Glicemia 91 mg/dL, creatinina 0,76 mg/dL, AST 22 U/L, ALT 27 U/L, GGT 31 U/L, TSH 1,86 mUI/L, Na 139 mmol/L, K 4,2 mmol/L. Colesterol total 198 mg/dL, LDL 118 mg/dL, HDL 58 mg/dL, TG 112 mg/dL. Sem alteração analítica com impacto na manutenção da sertralina.

Mantém-se sertralina 100 mg id. Reforçadas medidas de higiene do sono, regularização de horários, actividade física e intervenção alimentar face a aumento ponderal. Discutida eventual optimização terapêutica/alternativa com menor impacto metabólico se progressão ponderal ou recrudescimento afectivo. Sem indicação actual para alteração farmacológica. Consulta em 3 meses; antecipar se agravamento do humor, insónia persistente ou emergência de ideação autolesiva.

18-Nov-2024 Dr(a). Inês Valente (HUC-CARDIOLOGIA)

Reavaliação pós-observação SU por episódio de FA paroxística sintomática no início do mês, com palpitações rápidas sustentadas, desconforto torácico inespecífico e dispneia ligeira, sem síncope/presíncope. Conversão para RS durante permanência em SU, sem necessidade de cardioversão eléctrica. Desde alta sem novas crises de taquicardia sustentada, apenas palpit. muito breves/esporádicas, autolimitadas, sem correspondência em Holter prévio. Nega dor torácica de esforço, dispneia, ortopneia, DPN, edema periférico ou intolerância funcional nova. Sem hemorragia exteriorizada, equimoses anómalas, epistaxis ou queixas GI sob apixabano.

AP: FA paroxística dx 02/2023; doença de Crohn ileocólica, clinicamente quiescente sob imunossupressão; perturbação depressiva major em remissão parcial, seguimento Psiquiatria. Anemia ligeira previamente atribuída a DII. Apendicectomia 2015. Ecografia abdominal anterior com esteatose hepática ligeira. Sem HTA, DM, AVC/AIT, IC, doença coronária ou doença tiroideia conhecida. Alergia a sulfamidas, exantema maculopapular.

MH: apixabano 5 mg 12/12h, sem falhas referidas; bisoprolol 2,5 mg id; azatioprina 100 mg id, mesalazina 1,2 g 12/12h; sertralina 100 mg id. Boa tolerância global. Sem AINEs. Consumos alcoólicos ocasionais, sem padrão excessivo; sem tabagismo.

EO: bom estado geral, corada, hidratada, eupneica em repouso. TA 118/72 mmHg, FC 64 bpm regular, SpO2 99% ar ambiente, T 36,4 °C. Auscultação cardíaca em RS, S1/S2 normofonéticas, sem sopros, sem galope. AP sem fervores/sibilos. Sem ingurgitamento jugular, sem edemas maleolares.

ECG de 18/11/2025: ritmo sinusal, FC 62 bpm, eixo eléctrico normal, PR 158 ms, QRS 86 ms, QT 402 ms, QTc 408 ms. Sem pré-excitação, sem bloqueios de ramo, sem ondas Q patológicas. Repolarização ventricular sem alterações isquémicas agudas; ST isoeléctrico,



Diário Clínico

Consulta Externa

ondas T positivas em derivações inferiores e precordiais. Comparativamente ao ECG realizado em SU, já sem resposta ventricular rápida/traçado de FA então documentado.

Holter 24h de 07/11/2025 com ritmo sinusal predominante, FC média 68 bpm, mínima 47 bpm em período noturno e máxima 121 bpm em atividade. Sem pausas >2,0 s, sem bloqueio AV significativo. Extrassístoles supraventriculares raras, isoladas, sem salvas sustentadas; extrassístoles ventriculares muito escassas, monomórficas, sem pares ou taquicardia ventricular não sustentada. Não registados episódios de FA/flutter durante o período de monitorização. Diário sem correlação sintoma-arritmia relevante.

Ecocardiograma transtorácico de controlo revisto hoje. Ventrículo esquerdo não dilatado, diâmetro telediastólico 47 mm, espessuras parietais normais, sem hipertrofia; cinética segmentar homogénea, sem alterações da contractilidade regional. Função sistólica global preservada, FEVE biplano Simpson 63%; função longitudinal conservada, GLS -20%. Padrão de enchimento mitral compatível com função diastólica normal, relação E/e' média 7, sem evidência de elevação das pressões de enchimento. Aurícula esquerda com volume indexado 33 mL/m², no limite superior da normalidade, sem dilatação significativa; aurícula direita de dimensões normais. Ventrículo direito de dimensões e função preservadas, TAPSE 23 mm, S' tricúspide 12 cm/s. Válvula aórtica trivalvular, sem estenose ou insuficiência; válvulas mitral e tricúspide morfologicamente normais, insuficiência mitral/tricúspide mínima fisiológica. Sem derrame pericárdico, aorta ascendente não dilatada. PSAP estimada 24 mmHg. Sem alterações estruturais com potencial substrato evidente para progressão arritmica.

Analítica de 06/11/2025: Hb 11,7 g/dL, VGM 88 fL, leucócitos 6,4x10⁹/L, plaquetas 278x10⁹/L. Ferritina 24 ng/mL, ferro 58 µg/dL, saturação transferrina 17%. Creatinina 0,78 mg/dL, TFGe 95 mL/min/1,73m², ureia 27 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Mg 2,0 mg/dL, Ca 9,4 mg/dL. AST 21 U/L, ALT 24 U/L, GGT 31 U/L, bilirrubina total 0,5 mg/dL. TSH 1,46 mUI/L, T4L 1,10 ng/dL. PCR 1,8 mg/L. Col total 186 mg/dL, LDL 104 mg/dL, HDL 61 mg/dL, TG 103 mg/dL. Sem fator metabólico, tiroideu, renal ou eletrolítico precipitante identificável para o episódio recente.

FA paroxística, episódio sintomático isolado recente, atualmente em RS e clinicamente estável. CHA2DS2-VASc 1 por sexo feminino isolado; anticoagulação já instituída e bem tolerada, manter por ora atendendo ao padrão arritmico documentado e decisão previamente partilhada. Mantém apixabano 5 mg 12/12h e bisoprolol 2,5 mg id, sem indicação atual para aumento de dose ou antiarritmico. Reforçada adesão, evitar desidratação, estimulantes excessivos e automedicação com AINEs; vigilância de perdas hemáticas, particularmente no contexto de DII/imunossupressão.

Discutida estratégia futura de controlo de ritmo. Sem indicação imperativa imediata para ablação, dada baixa carga arritmica, ecocardiograma sem cardiopatia estrutural relevante e boa estabilidade atual. Se recorrência de FA sustentada/sintomática, com impacto



Diário Clínico

Consulta Externa

funcional ou necessidade repetida de recurso ao SU, referenciar para consulta de Eletrofisiologia para discussão de isolamento de veias pulmonares; explicados sumariamente objetivos, probabilidade de controlo de sintomas e riscos do procedimento. Repetir Holter prolongado/monitorização de eventos se novas palpitações. Consulta Cardiologia em 6 meses, antecipar perante recorrência, síncope, dispneia ou hemorragia.

14-Jan-2025 Dr(a). Inês Valente (HUC-DERMATOLOGIA)

AP: doença de Crohn ileocólica, em remissão sob azatioprina/mesalazina; FA paroxística hipocoagulada; perturbação depressiva em seguimento. Sem antecedentes pessoais de eczema, psoríase ou neoplasia cutânea. Alergia a sulfamidas.

Observada por placa pruriginosa única no antebraço E, face flexora, com cerca de 3,2 x 2,1 cm, instalada há ~10 dias. Sem febre, dor, exsudação, vesiculação ou lesões em outras localizações. Nega novo fármaco sistémico. Refere uso recente repetido de produto de limpeza/perfume na área e fricção por manga de tecido sintético. Sem contacto conhecido com plantas, animais ou metais. Sem queixas digestivas ou articulares concomitantes.

EO: TA 118/72 mmHg, FC 64 bpm regular, SpO2 99% AA, T 36,4°C. Bom estado geral. Face flexora proximal do antebraço E com placa eritematosa mal delimitada, discretamente infiltrada, xerótica, com fina descamação e escoriações lineares superficiais por coçadura. Sem bordo anular ativo, sem pústulas, crostas melicéricas, fissuração, necrose ou sinais de sobreinfecção. Pele circundante sem alteração. Restante tegumento acessível sem lesões eczematosas, urticariformes ou descamativas. Unhas e mucosas sem alterações.

Quadro compatível com dermatite eczematosa localizada, provável irritativa/de contacto; sem elementos clínicos para dermatofitose, celulite ou manifestação cutânea associada à DII. Sem indicação para biópsia, testes epicutâneos ou estudo analítico nesta fase.

Mometasona furoato 0,1% creme, camada fina 1x/dia durante 7 dias, depois suspender; não aplicar em pele erosionada. Emoliente sem perfume 2-3x/dia e após banho. Evitar fragrâncias, detergentes/produtos de limpeza directos e fricção local; luvas em tarefas húmidas. Reavaliar se persistência >3 semanas, extensão, exsudação/dor ou recorrência; nessa eventualidade ponderar testes de contacto.

22-Fev-2025 Dr(a). Inês Valente (HUC-GASTRENTEROLOGIA)

Seguimento D. Crohn ileocólica, dx 2018, sob AZA/5-ASA. AP: FA paroxística hipocoagulada; perturbação depressiva em seguimento Psiq. Sem idas SU/internamentos desde última consulta.



Diário Clínico

Consulta Externa

Mantém bem-estar habitual. Sem dor abdominal, distensão ou náuseas. Trânsito 1-2 dejetões/dia, moldadas, sem muco, sangue ou urgência; sem dejetões nocturnas/incontinência. Sem febre, anorexia ou perda ponderal. Nega artralrias inflamatórias, lesões cutâneas, aftose oral ou queixas oculares. Sem intercorrências infecciosas recentes. Adesão referida como regular, sem omissões significativas. Tolera azatioprina 100 mg id e mesalazina 1,2 g 2id, sem intolerância GI, exantema, citopenias conhecidas ou infecções recorrentes.

EO: bom estado geral, normocorada, hidratada. TA 118/72 mmHg, FC 64 bpm regular, SatO2 99% AA, T 36,4°C. Abdómen plano, depressível, indolor superficial/profundamente, sem defesa, massas ou organomegalias. Sem edema periférico.

Analítica 14/02/26 revista: Hb 11,3 g/dL, Ht 35,1%, VGM 83 fL, HGM 26,8 pg, RDW 14,9%; leucócitos $5,8 \times 10^9/L$, neutrófilos $3,4 \times 10^9/L$, linfócitos $1,6 \times 10^9/L$, plaquetas $286 \times 10^9/L$. Reticulócitos 1,1%; ferritina 18 ng/mL, ferro 48 µg/dL, transferrina 292 mg/dL, saturação transferrina 12%. PCR 1,2 mg/L, VS 11 mm/h. Creatinina 0,76 mg/dL, ureia 27 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,2 mmol/L, albumina 4,3 g/dL. AST 19 U/L, ALT 21 U/L, GGT 24 U/L, FA 72 U/L, bilirrubina total 0,5 mg/dL. Vit. B12 356 pg/mL, ácido fólico 8,9 ng/mL, vit. D 28 ng/mL. Calprotectina fecal 46 µg/g. Sem elevação de marcadores inflamatórios; sem alteração renal/hepática ou citopenias sob AZA. Anemia microcítica ligeira, ferropénica, estável face a controlo prévio (Hb 11,2 g/dL), sem repercussão clínica.

Doença de Crohn em remissão clínica e bioquímica. Manter AZA 100 mg id e mesalazina 1,2 g 2id. Sem indicação para escalada terapêutica. Reforçada vigilância de febre, dor abdominal persistente, diarreia/sangue nas fezes; evitar AINEs. Repetir hemograma, perfil férrico, função renal/hepática, PCR e calprotectina antes de próxima consulta, 6 meses.

14-Mai-2026 Dr(a). Inês Valente (HUC-GASTROENTEROLOGIA)

AP: DC ileocólica dx 2018, habitualmente em remissão sob AZA/5-ASA. FA paroxística sob apixabano. Seguimento após recurso SU em Abril por provável exacerbação de DC, com dor FID/periumbilical, aumento nº dejetões e urgência defecatória, sem necessidade de internamento.

Sob prednisolona 20 mg/d em desmame desde alta. Refere melhoria progressiva; actualmente 1-2 dejetões/dia, moldadas, sem sangue, muco ou dejetões nocturnas. Dor abdominal residual episódica, ligeira, sem relação consistente com alimentação, francamente menos frequente. Sem náuseas/vómitos, febre, anorexia ou perda ponderal. Sem artralrias inflamatórias, lesões cutâneas, queixas oculares ou perianais. Tolerância alimentar mantida.



Diário Clínico

Consulta Externa

MH: azatioprina 100 mg id, mesalazina 1,2 g 2id, prednisolona 20 mg id, apixabano 5 mg 2id, bisoprolol 2,5 mg id, sertralina 100 mg id. Sem interrupções da AZA ou mesalazina. Sem AINEs. Alergia a sulfamidas.

EO: bom estado geral, apirética 36,4°C, TA 118/72 mmHg, FC 68 bpm regular, SpO2 99% ar ambiente. Abdómen plano, RHA presentes, depressível; discreto desconforto à palpação profunda FID, sem defesa, sem massa ou organomegalias. Sem sinais de desidratação.

Analítica SU 18/04/26: Hb 11,6 g/dL, VGM 86 fL, leucócitos $8,9 \times 10^9/L$, neutrófilos $6,1 \times 10^9/L$, plaquetas $348 \times 10^9/L$. PCR 18,4 mg/L, VS 31 mm/h. Creatinina 0,74 mg/dL, ureia 27 mg/dL, Na 139 mmol/L, K 4,1 mmol/L, AST 19 U/L, ALT 22 U/L, FA 81 U/L, GGT 24 U/L, bilirrubina total 0,4 mg/dL, albumina 3,8 g/dL. Ferritina 24 ng/mL, ferro 42 µg/dL, saturação transferrina 13%. Calprotectina fecal colhida em contexto agudo 486 µg/g. Coprocultura, pesquisa de toxina/PCR C. difficile e parasitológico negativos.

Quadro compatível com actividade inflamatória intestinal ligeira-moderada, com resposta clínica ao corticóide. Manter AZA 100 mg/d e mesalazina 1,2 g 2id. Desmame prednisolona: 15 mg/d 7 dias, depois 10 mg/d 7 dias, 5 mg/d 7 dias e suspender se manutenção de remissão clínica; contactar precocemente se recrudescimento de dor, diarreia, rectorragia ou febre. Repetir hemograma, PCR, função hepática/renal e calprotectina fecal em 4-6 sem. Reavaliação consulta após resultados; ponderar optimização terapêutica/endoscópica se calprotectina persistentemente elevada.

12-Jun-2026 Dr(a). Inês Valente (HUC-PSIQUIATRIA)

Consulta seguimento. AP: perturbação depressiva major, em remissão parcial; doença de Crohn ileocólica, recente agudização sob prednisolona em desmame; FA paroxística anticoagulada.

Refere humor globalmente mais baixo nas últimas semanas, com maior labilidade emocional, irritabilidade ocasional e sentimento de sobrecarga face à reativação da patologia intestinal, vigilância clínica e impacto funcional associado. Sem anedonia marcada. Mantém capacidade de desempenhar tarefas laborais/familiares, ainda que com maior esforço subjetivo. Sem isolamento significativo. Nega desesperança estruturada, sentimentos de inutilidade ou culpa patológica. Sem ideação suicida atual ou prévia recente, sem plano, intenção ou comportamentos autolesivos. Sem heteroagressividade.

Sono com insónia inicial ocasional, sobretudo em dias de maior preocupação com sintomas gastrointestinais; latência aumentada variável, habitualmente <1h. Sem despertares frequentes relevantes. Sem pesadelos. Apetite sem alteração significativa; reconhece aumento ponderal gradual prévio, sem compulsão alimentar. Energia



Diário Clínico

Consulta Externa

discretamente diminuída, sem lentificação psicomotora percecionada. Nega consumo de álcool em excesso, canabinóides ou outras SPA.

MH: sertralina 100 mg id, tolerada; sem náuseas, disfunção sexual referida, tremor ou agravamento ansioso atribuível. Mantém restante terapêutica prescrita por Gastrenerologia/Cardiologia. Adesão adequada.

EO: TA 118/74 mmHg, FC 68 bpm, SatO2 99% ar ambiente, T 36,4 °C. Apresentação cuidada, contacto fácil, colaborante. Vigil, orientada auto/alo e temporalmente. Discurso espontâneo, organizado, débito e volume normais. Humor referido “mais em baixo”; afeto discretamente constricto, reativo e congruente. Pensamento formal sem aceleração, bloqueios ou desorganização; conteúdo sem ideação delirante, ideias de referência ou fenómenos obsessivos incapacitantes. Sem alterações percetivas. Atenção e memória de evocação clinicamente preservadas. Juízo crítico e insight mantidos.

Quadro compatível com agravamento ligeiro/situacional de sintomatologia depressivo-ansiosa no contexto de exacerbação de doença crónica, sem critérios de episódio depressivo major atual nem necessidade de alteração farmacológica aguda. Mantém sertralina 100 mg id. Reforçada psicoeducação sobre relação stress-doença física, estruturação de rotinas, higiene do sono, técnicas de redução de ativação ao deitar e manutenção de rede de suporte. Orientada para antecipar contacto se agravamento sustentado do humor, ideação autolesiva, insónia persistente ou incapacidade funcional. Seguimento em 8-10 sem.; manter articulação com Gastrenerologia.

20-Jul-2026 Dr(a). Rui M. Tavares (HUC-CARDIOLOGIA)

Consulta anual de vigilância de FA paroxística. Sem recorrência de episódios sintomáticos desde 11/2025; nega palpitações sustentadas, ritmo irregular percepcionado, pré-síncope/síncope, dor torácica, dispneia, ortopneia, DPN ou edema periférico. Sem idas a SU, cardioversão ou internamentos por causa cardiovascular no intervalo. Mantém atividade habitual sem limitação funcional; NYHA I. Sem hemorragia exteriorizada, epistaxis persistente, gengivorragia, hematúria, melenas ou rectorragias sob anticoagulação. Adesão referida como regular, sem omissões relevantes.

AP: FA paroxística dx 02/2023; doença de Crohn ileocólica, habitualmente em remissão, seguida em Gastrenerologia; episódio recente tratado com prednisolona em desmame. Perturbação depressiva major, remissão parcial, acompanhada em Psiquiatria. Anemia ligeira em contexto inflamatório sob vigilância. Esteatose hepática ligeira conhecida. Apendicectomia 2015. Sem HTA, DM, AVC/AIT, IC, doença coronária ou doença arterial periférica conhecidos. Palpitações breves ocasionais prévias sem correlação em Holter; atualmente ausentes. Alergia a sulfamidas, exantema maculopapular.



Diário Clínico

Consulta Externa

MH: apixabano 5 mg 12/12h, bisoprolol 2,5 mg id, azatioprina 100 mg id, mesalazina 1,2 g 12/12h, sertralina 100 mg id; prednisolona 20 mg id em redução progressiva conforme orientação de Gastreenterologia. Sem AINEs. Sem terapêutica antiarrítmica.

EO: vigil, colaborante, eupneica em ar ambiente. TA 118/72 mmHg, FC 64 bpm regular, SpO2 99%, T 36,4 °C, peso 71,8 kg. Auscultação cardíaca com S1/S2 normofonéticas, ritmo regular, sem sopros audíveis. Sem ingurgitamento jugular; membros inferiores sem edemas, pulsos periféricos palpáveis e simétricos. AP sem alterações relevantes à auscultação, sem crepitações.

ECG de 12 derivações efectuado em consulta: ritmo sinusal regular, 63 bpm, eixo eléctrico intermédio. Onda P de morfologia e duração habituais, condução AV conservada com PR 164 ms. QRS estreito, 86 ms, sem bloqueio de ramo, sem ondas Q patológicas ou critérios de hipertrofia ventricular. Repolarização sem infradesnivelamento/elevação de ST, ondas T sem alterações isquémicas agudas; QT 402 ms, QTc 411 ms. Comparativamente ao ECG de 07/2025, mantém ritmo sinusal e traçado globalmente sobreponível, sem alterações dinâmicas.

Revisto Holter 24h de 10/2025: duração útil 23h41min, ritmo sinusal predominante, FC média 68 bpm, mínima 47 bpm em período nocturno e máxima 118 bpm em actividade diurna. Sem episódios documentados de FA/flutter, pausas superiores a 2,0 s ou bloqueio AV de alto grau. Extrassistolia supraventricular rara, 36 ESV isoladas, sem salvas; extrassistolia ventricular muito escassa, 11 EV monomórficas isoladas. Diário sem registo de sintomas com correspondência arrítmica. Achados compatíveis com adequado controlo de frequência basal sob baixa dose de bisoprolol.

Ecocardiograma transtorácico de 08/2025 revisto: ventrículo esquerdo não dilatado, diâmetro telediastólico 47 mm, espessuras parietais normais e massa ventricular dentro do intervalo de referência. Função sistólica global preservada, FEVE estimada 62% por Simpson biplano, sem alterações segmentares da contractilidade. Aurícula esquerda discretamente aumentada, volume indexado 35 mL/m²; aurícula direita sem dilatação significativa. Válvula mitral estruturalmente normal, insuficiência mitral ligeira funcional; válvulas aórtica e tricúspide sem lesões hemodinamicamente relevantes. VD de dimensões e função preservadas, TAPSE 23 mm; PSAP estimada 24 mmHg, sem sinais indirectos de HTP. Sem derrame pericárdico, aorta ascendente visualizada com calibre normal. Sem alteração relevante face ao exame de 2023.

Analítica de 06/2026: Hb 11,8 g/dL, VGM 88 fL, leucócitos 6,4x10⁹/L, plaquetas 278x10⁹/L. Creatinina 0,78 mg/dL, TFGe 95 mL/min/1,73m², ureia 29 mg/dL, Na 140 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Mg 2,0 mg/dL. AST 19 U/L, ALT 24 U/L, GGT 31 U/L, bilirrubina total 0,5 mg/dL. TSH 1,76 mUI/L, FT4 1,12 ng/dL. PCR 3,8 mg/L. Função renal e hepática mantida, sem condicionantes laboratoriais actuais à dose de apixabano.



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
COIMBRA

NOME COMPLETO PACIENTE

SEXO Dta Nasc: XXXX-XX-XX (XX anos) *XXXX*

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

Diário Clínico

Consulta Externa

CHA2DS2-VASc 1 por sexo, mantendo-se indicação de anticoagulação previamente individualizada no contexto de FA documentada e perfil global; HAS-BLED baixo. Sem critérios clínicos ou ecocardiográficos para alteração da estratégia actual. Manter apixabano 5 mg 12/12h e bisoprolol 2,5 mg id. Reforçada toma rigorosa, não suspender anticoagulante sem articulação prévia, nomeadamente perante procedimentos endoscópicos relacionados com Crohn. Alertada para sinais hemorrágicos, palpitações persistentes, síncope, dispneia ou dor torácica. ECG/Holter antecipados se recorrência sintomática. Consulta anual, com ECG e hemograma/função renal/hepática prévios.